

合理用药

双人逐页演讲稿

配套文件：合理用药_双人 35 分钟.pptx | 30 页主讲+3 页参考资料附页

目标：面向具有高中生物基础的非医学专业大一学生，学会处理常见用药选择并识别误区。全部小苏故事均为虚构情境；真实研究单独标明。

35 分钟时间与分工

部分	主讲页	时间	内容
第一部分	1—5	00:00—05:00	基本原则
第二部分	6—19	05:00—22:00	五类宿舍误区
第三部分	20—26	22:00—30:00	安全用药方法
第四部分	27—30	30:00—35:00	简单综合选择题与收尾

甲主讲第 1—16 页，计划 16 分 55 秒；乙主讲第 17—30 页，计划 18 分 05 秒。第 29 页甲补充约 15 秒，第 30 页共同收尾，实际发言时间更接近。第 16 页末交接，不中途介绍新身份。

互动时，一人主持，另一人观察举手并翻页。不要求同学解释观点，不询问私人疾病史。参考资料页设为隐藏，课堂主线不会自动进入附页。

排练与控时

计时是演讲目标，不是自动播放。稿件约 5700 个汉字，另有停顿、读题、举手与同桌讨论，按自然讲解语速排练后校准。首次完整计时，优先把总时长控制在 34—36 分钟；不要为凑时间机械拖慢每句话。

到第 5 页末应约 5 分钟，第 19 页末约 22 分钟，第 26 页末约 30 分钟。超时 1 分钟：压缩第 18 页重复解释约 30 秒，并将第 19 页同桌讨论与点评合计缩短 30 秒。提前 1 分钟：按稿中停顿完整读图，补充解释第 8 页“模拟任务”和第 13 页“两种口径”，不要临时增加医学结论。

使用 PowerPoint 演示者视图查看备注。翻页采用手动点击，不设自动计时；答案页在投票后再显示。把封面的“同学甲/同学乙”替换成姓名。正式展示前，在实际电脑上检查字体和投影。

01 | 合理用药：给宿舍药箱上堂课

主讲：甲 建议：45 秒 累计：00:00—00:45

舞台提示：甲主讲；乙操作翻页。

甲：大家好。今天我们聊一个进入大学后越来越需要自己做决定的问题：身体不舒服时，药到底该怎么用？离开父母的提醒，宿舍药箱、室友推荐和手机搜索，可能成了我们的第一反应。但名字熟悉，不代表适合自己；药吃得多，也不代表好得快。接下来我们用五类校园情境和几轮举手选择，练习几个能直接用上的判断。我们不考药名，也不背剂量表，目标是学会看什么、问什么，以及什么时候应该就医。

02 | 室友感冒了，你先做哪一步？

主讲：甲 建议：90 秒 累计：00:45—02:15

舞台提示：10 秒阅读+三轮举手约 25 秒；不追问个人用药史。

甲：先进入一个虚构情境。小苏明天有课，今天流鼻涕、喉咙不舒服，室友递来两盒感冒药，另一位室友说，加一粒抗生素更保险。现在只选第一步，不需要给出具体药名。请大家先用十秒看完三个选项。

【静默 10 秒】甲依次读 A、B、C，每个选项留 5 秒举手。乙观察大致人数，不做精确统计，也不点名问理由。

甲：谢谢。无论你刚才选了哪个，今天都会解释这些选择背后的差别。选择 B，是先获取决定所需的信息；这并不等于自己诊断所有疾病。我们先把答案放在心里，结束时再看看能否把这个动作做得更完整。

03 | 合理用药，要同时过四关

主讲：甲 建议：60 秒 累计：02:15—03:15

甲：合理用药可以用四个词记住：安全、有效、经济、适宜。安全不是承诺任何药都没有风险，而是识别禁忌和可能的不良反应。有效，是药物针对的问题与实际需要相符。经济，是在满足治疗需要的前提下，避免不必要的药物和花费。适宜，则提醒我们，同一个药对室友合适，对自己不一定合适，年龄、过敏史、正在

使用的其他药物，都可能影响选择。所以开场选 B，是先把这些信息补齐，而不是看到一个症状就直接往药箱里伸手。

本页依据：S1

04 | 高中生物连接：药物也要找“靶点”

主讲：甲 建议：60 秒 累计：03:15—04:15

甲：回忆高中生物，我们学过蛋白质的结构与功能，也学过酶和细胞间的信息传递。理解药物，可以先用一个简化模型：有些药物与受体结合，改变信号；有些药物影响酶的作用，改变某个反应过程。图中用形状匹配表示识别，它只是一种示意，并不是所有药物都像一把钥匙只开一把锁。相同或相关的靶点可能存在于多个部位，所以治疗作用和其他作用可能同时出现。稍后讲抗过敏药为什么让人困，就会用到这个思路。

本页依据：S8

05 | 今天的路线：从会判断，到会行动

主讲：甲 建议：45 秒 累计：04:15—05:00

甲：今天分四部分。我们已经用五分钟建立基本原则，接着用十七分钟看宿舍里容易遇到的五类误区：重复成分、抗生素、备考提神、抗过敏药，以及药物与饮酒。然后用八分钟把知识变成一套操作方法，最后五分钟做一道简单综合题。甲负责前半段，乙负责后半段；投票时另一位同学帮忙观察。大家只需要做选择，不必临时组织一段观点，也不需要公开自己的疾病或用药经历。

06 | 案例①：两盒感冒药，真是“双保险”？

主讲：甲 建议：75 秒 累计：05:00—06:15

甲：第一幕还是小苏。他拿到两盒药，一盒包装强调缓解头痛，一盒写着缓解感冒症状，于是直觉上觉得，一个管头，一个管感冒，应该互不冲突。但宣传的症状不同，不代表里面的有效成分不同。比如，对乙酰氨基酚既可以作为单一成分用于解热镇痛，也可能出现在复方感冒药里。两盒一起吃时，身体接收到的是所有来源的总量。我们在这里不推荐具体品牌，也不演示个人用药剂量，先练最重要的动作：把两份说明书的成分栏摆在一起比较。包装上的大字可以吸引注意，成分栏才是判断重复的依据。

本页依据：S2

07 | 看成分，才能发现“隐形重复”

主讲：甲 建议：60 秒 累计：06:15—07:15

甲：这两个标签是教学示意，不对应具体产品。请看红色框出的同一个名字：对乙酰氨基酚。即使两盒药的商品名、用途描述和包装颜色不同，这个成分仍然会重复进入体内。判断时，不能把药盒当作两个互不相关的单位。特别是复方药，一盒里就可能有多种有效成分，所以更需要逐项核对。看到重复后，先不要自行叠加；拿着具体药名、规格和已经服用的时间，向药师确认。如果怀疑已经超量，也不能因为暂时没有不舒服就继续等，应及时获得医疗帮助。

本页依据：S2

08 | 真实研究：模拟用药，也容易出错

主讲：甲 建议：60 秒 累计：07:15—08:15

甲：我们用一项研究说明，读懂药品标签并没有想象中简单。研究发表于 2012 年，纳入美国门诊的 500 名成人，让他们完成非处方对乙酰氨基酚产品的模拟用药任务。23.8%的参与者在单一产品任务中安排出了超过研究判定阈值的用量，45.6%在联用任务中出现重复成分造成的潜在超量。请注意，这是模拟任务，不代表这些人实际中毒，更不能推算我们班或中国大学生的发生率。两项指标也可能来自同一名参与者，所以不能相加。我们从图中带走的结论是：核对成分需要一个具体动作，不能只靠“我应该记得”。

本页依据：S3

09 | 选择题②：两盒都含相同成分，怎么办？

主讲：甲 建议：75 秒 累计：08:15—09:30

舞台提示：阅读 10 秒；举手约 25 秒；其余时间复述问题并转场。

甲：现在把刚才学到的动作再练一次。已知两盒药都含有对乙酰氨基酚，我们仍然不知道具体规格、适用人群，也不知道小苏还吃过什么。三个选项中，哪一个最稳妥？请先安静想十秒。

【静默 10 秒】甲依次读 A、B、C，乙观察举手，各留 5 秒。

甲：这题不需要计算药量。特别留意 B，它看起来很谨慎，因为把量减了，但它仍然是在缺少信息时自行拼接方案。我们今天练的是先识别风险，再补齐信息，而不是凭感觉把两盒药重新配方。下一页揭晓。

本页依据：S2

10 | 答案 C：先核对，再决定

主讲：甲 建议：30 秒 累计：09:30—10:00

甲：答案是 C。A 忽略了成分，B 在不知道规格和总量时自行改方案，二者都不可靠。C 把操作顺序摆正：先不叠加，再核对，必要时请药师判断。询问时最好带上包装或清晰照片，同时说清已经吃过什么、吃了多少和什么时候吃的，这样对方才能给出有依据的建议。

本页依据：S2

11 | 案例②：抗生素，不是感冒的通用答案

主讲：甲 建议：75 秒 累计：10:00—11:15

甲：第二个误区是把抗生素当成感冒时的保险药。回到高中生物，细菌具有细胞结构，病毒没有完整的细胞结构，需要利用宿主细胞复制。不同类别的抗生素，可以作用于细菌的细胞壁合成、蛋白质合成等过程；对引起普通感冒的病毒，它们没有相应的治疗作用。所以流鼻涕、嗓子痛，并不能自动推出“应该吃抗生素”。当然，出现这些症状也可能有其他原因，少数病毒感染之后还可能发生细菌感染，是否需要抗生素需要评估。我们能做的是描述症状、接受判断，而不是自己拿剩药试试看。

本页依据：S4; S11

12 | 耐药：被筛选出来的是细菌

主讲：甲 建议：80 秒 累计：11:15—12:35

甲：为什么不必要地用抗生素还会带来后续问题？可以借助高中生物的自然选择来理解。图中蓝色代表敏感细菌，红色代表具有耐药性的细菌。这些差异可以来自遗传变异，也可以来自耐药基因的获得。面对某种抗生素，敏感细菌更容易被抑制，具有相应耐药性的细菌可能存活并繁殖，于是群体中耐药菌的比例上升。图中的数量是教学示意，不是实验数据。这里最容易说错的一句话是“我的身体耐药了”。更准确地说，是病原菌对药物产生了抵抗能力。这个过程还涉及基因传播等因素，今天先记住选择压力这一条主线。

本页依据：S4; S5

13 | 耐药风险，有多大？看清数据口径

主讲：甲 建议：70 秒 累计：12:35—13:45

甲：这里用的是 2022 年发表于《柳叶刀》的研究，对 2019 年全球细菌耐药负担进行估计。较宽的“相关”口径约为 495 万例死亡，而“归因”口径约为 127 万例。两者的比较假设不同：前者比较没有这类耐药感染的情况，后者比较感染仍然发生、但细菌对药物敏感的情况。它们不能相加，也不能理解为所有死亡都由个人乱吃抗生素造成。图上的细线是不确定性区间，提醒我们这些数字是模型估计，不是精确清点。我们引用这组历史数据说明耐药问题的重要性，并不把它称为今年的最新统计。

本页依据：S5

14 | 抗生素的三条行动规则

主讲：甲 建议：55 秒 累计：13:45—14:40

甲：回到我们自己能做的事，记住三条。第一，不因为感冒或嗓子痛就自行启用抗生素。第二，不把自己剩下的药分给室友，也不拿室友的处方照着用。第三，确实需要时按医生给出的剂量、间隔和疗程使用，不因为感觉好一点就自行停药，也不为了“彻底一点”擅自延长。这里不是让大家出现严重反应也硬撑着吃完，而是出现异常、疗效不理想，或不知道该如何继续时，及时联系医生或药师，由专业人员调整方案。

本页依据：S4

15 | 案例③：“备考外挂”，真的值得试？

主讲：甲 建议：60 秒 累计：14:40—15:40

甲：第三个情境发生在考试周。小苏看到“提升专注、快速提分”的宣传，又听说有人借用治疗注意缺陷多动障碍的处方药来熬夜。这里要分开看：保健食品与药品不是一回事，不能用保健食品替代疾病治疗，也不能把某种功能声称直接等同于提高考试成绩。而处方兴奋剂有明确适应证，非医疗使用存在失眠、焦虑、成瘾及过量等风险，不能因为别人说有效就借来试。对需要这些药物的患者，规范治疗有价值；我们反对的是把别人的处方当作通用学习工具。

本页依据：S6; S7

16 | 案例④：鼻子舒服了，上课却困了

主讲：甲 建议：75 秒 累计：15:40—16:55

舞台提示：此页未交接。甲累计 16 分 55 秒；乙从第 17 页开始。

甲：第四幕，小苏为了缓解过敏症状服了药，鼻子舒服了，坐进教室却特别想睡觉。这并不一定是药物没有起效，而可能是某些抗组胺药带来的嗜睡作用。有些药更容易让人困，有些相对较少，但个人反应也有差异。因此，选择时要说清自己的需求，例如白天有课、需要通勤，并向药师询问是否容易嗜睡。第一次使用时尤其应留意反应，困倦或反应变慢时，不要驾驶、骑车或做其他需要高度警觉的活动。也不要自己用酒精或其他药物去“抵消”这种感觉。

甲：为什么一种药既影响鼻子，也影响清醒程度？下面交给乙，接着用生物知识解释。

本页依据：S8

17 | 同一条信号，在不同部位有不同作用

主讲：乙 建议：65 秒 累计：16:55—18:00

乙：接着刚才的问题。组胺是一种参与信号传递的物质，在外周组织中，它参与部分过敏症状；在脑内，相关信号也参与维持清醒状态。部分抗组胺药能够进入脑内，影响相应的受体作用，因此在缓解过敏症状的同时，也可能让人困倦。这里可以连接高中生物中的信息传递和内环境：同一种信号分子，在不同位置可能参与不同功能。我们把复杂机制压缩成这张示意图，是为了说明作用为什么可能同时发生，而不是让大家按这张图自行选择药物或调整剂量。

本页依据：S8; S14

18 | 案例⑤：聚餐的酒，先缓一缓

主讲：乙 建议：120 秒 累计：18:00—20:00

乙：第五个情境是聚餐。小苏白天吃了药，晚上被劝“就喝一点”。判断能不能一起用，不能只凭酒量，也不能只靠“上次没事”。酒精可能与多种药物相互作用，特别是与具有镇静作用的药物一起使用时，可能进一步影响警觉性和协调能力。对某些药物，风险还可能涉及肝脏、胃肠道等，但不同药物的机制和影响并不一样。

还有一个常见想法：把喝酒和吃药错开两小时就安全。这个时间不能通用，因为不同药物在体内停留的时间不同，饮酒情况和个体差异也会影响结果。拿不准时，最直接的行动是先不喝，带着具体药名去确认。

顺便说说送服药物。普通口服片剂和胶囊通常选择白水，并按说明书要求服用；不要默认咖啡、果汁、牛奶都能替代。但剂型有差别，例如含服或咀嚼的药物有自己的要求，所以最终仍然要看这盒药的具体说明。

本页依据：S8; S9; S13

19 | 选择题③：聚餐前，选哪条路线？

主讲：乙 建议：120 秒 累计：20:00—22:00

舞台提示：同桌讨论 20 秒+举手约 25 秒；答案口头公布，不追问开放观点。

乙：这一题仍然只选下一步。今天已经服过抗过敏药，但没有确认具体药品的饮酒要求，晚上聚餐时怎样做更合适？请大家看完三个选项，可以和旁边同学小声商量二十秒，只需要最后选一个字母。

【同桌讨论 20 秒】甲负责依次示意 A、B、C，乙主持，给每个选项约 5 秒举手。

乙：这里有两个很容易误导人的线索，一个是时间，一个是醉不醉。药物相互作用不能靠统一间隔来排除，也不是只有喝醉才可能发生。正确答案是 B：看这一个具体药品的要求；如果暂时不能确认，先不喝。即使全班都选对，也值得保留这个动作，因为聚餐时的社交压力容易让人把已经知道的原则放到一边。现在五个情境都看过了，我们把它们整理成一个可以重复使用的方法。

本页依据：S8; S9

20 | 安全用药四步：看、核、问、记

主讲：乙 建议：60 秒 累计：22:00—23:00

乙：第三部分，我们把前面的例子浓缩成四个动作：看、核、问、记。看，是观察症状，也看说明书和需要就医的信号。核，是核对成分有没有重复，剂量与时间是否符合要求，自己有没有相关禁忌。问，是把不确定的地方交给医生或药师确认，不用猜测填空。记，是记录已经用过的药、时间、用量以及出现的反应。上一题选 B，就把“这盒药能不能配酒”的不确定性变成了一个清楚的咨询问题。这四步是课堂助记法，不是替代诊疗的专业流程。

本页依据：S1; S2; S8; S9

21 | 说明书很长？先定位这六处

主讲：乙 建议：90 秒 累计：23:00—24:30

乙：看到密密麻麻的说明书，不少人的反应是只找“一次几片”。更有效的办法，是先定位六类信息。第一，成分和通用名，解决“我究竟在吃什么”。第二，适应证，确认它用于什么情况。第三，用法用量，包含每次多少、间隔多久以及如何服用。第四，禁忌和注意事项，查看过敏史、既往疾病和特殊人群等相关要求。第五，相互作用与不良反应，看看与其他药物、食物饮料是否存在需要注意的地方。第六，贮藏条件和有效期，确认药品是否仍适合使用。

这张是重新设计的阅读示意，不是实际产品的说明书，也不能替代完整说明书。如果处方要求与自己的理解不一致，应向开方医生或药师核实，而不是自己随意选一种理解执行。

本页依据：S1; S2; S8

22 | 时间、剂量、剂型，都别凭感觉改

主讲：乙 建议：70 秒 累计：24:30—25:40

乙：用药过程中的很多问题，不是药选错了，而是自己改变了使用方式。比如漏了一次，不要自动理解成下次吃双倍。不同药物的处理方法不同，先查说明书，拿不准就问药师。再比如疗程，按处方使用，同时留意症状与反应；出现疑问要及时沟通，不能自行加量或延长。还有剂型，一些缓释或肠溶制剂依赖特定结构控制释放位置和速度，随意掰碎、咀嚼或打开胶囊，可能改变原先设计。也不是说所有带刻痕的药都不能分，而是能不能分、怎样分，应以具体产品说明为准。

本页依据：S10; S13; S4

23 | 问药师时，把信息一次说清

主讲：乙 建议：60 秒 累计：25:40—26:40

乙：咨询是否有效，很大程度取决于我们提供的信息。可以按三句话组织。第一，我有什么症状，持续多久，正在变好还是加重。第二，我正在使用哪些药物或保健食品，具体药名和规格是什么，已经什么时候用了多少。第三，我有哪些已知药物过敏史、既往疾病或特殊情况。最好把药盒和说明书带上，或者拍清楚成分、规格和用法用量。只说“那种白色药片”，专业人员也难以准确判断。如果需要描述私密情况，可以单独咨询，不必在课堂或宿舍群里公开。

本页依据：S2; S1

24 | 什么时候，不该继续自己试药？

主讲：乙 建议：75 秒 累计：26:40—27:55

乙：合理用药还包括知道什么时候停止自己试错。用药后出现呼吸困难、喉部或舌头肿胀、明显意识异常等情况，可能是严重反应，应立即寻求急救，在国内拨打 120。不要靠继续加药来压住症状。怀疑超量或误服，也要及时获得医疗帮助，有些问题并不一定马上表现出来。就诊时带上药盒和已经服用的时间、用量记录。如果不是急症，但症状持续、反复或越来越重，也应该按药品说明书的就医提示及时就诊。我们列的是几个重要信号，不是完整清单，更不是要大家在宿舍自行鉴别各种严重疾病。

本页依据：S2; S11; S12

25 | 宿舍药箱：留信息，也留秩序

主讲：乙 建议：65 秒 累计：27:55—29:00

乙：说到药箱，最重要的不是囤得多，而是需要时能认清。药品尽量保留原包装和说明书，避免把不同药片混在一个没有标签的小盒子里。检查有效期，也检查包装上的贮藏要求，不能把“放冰箱”当作所有药物的统一保存方法。自己的处方药不要分享给室友，过期或不再需要的药品按当地药品回收或分类要求处理。再保留一个简单的用药记录，例如手机备忘录，写药名、时间、用量和反应。这样复诊或咨询时，信息会比凭印象回忆更准确。

本页依据：S2; S4

26 | 把五个误区，换成五个动作

主讲：乙 建议：60 秒 累计：29:00—30:00

乙：在进入挑战前，我们把五个案例各换成一个动作。两盒感冒药放在面前，先核对成分。感冒后想到抗生素，先确认是否真正需要。备考时有人推荐所谓外挂，不借用别人的处方药，也不相信保证提分的宣传。吃抗过敏药后感到困倦，查看注意事项并避开风险活动。聚餐想喝酒，先确认具体药物的要求。我们没有要求大家记住几十个药名，而是练习在几个关键位置停一下。下面的小测只组合这些已经出现的动作，没有新知识，也不需要计算。

27 | 综合挑战：小苏今晚怎么安排？

主讲：乙 建议：60 秒 累计：30:00—31:00

乙：最后进入综合挑战，小苏再次登场。这次信息更完整：他今天已经服用一种复方感冒药，晚上觉得还没完全舒服，想再加另一盒，同时准备去聚餐。现在两盒药的成分没有核对，饮酒要求也不清楚，症状目前较轻，没有我们刚才提到的严重急症表现。这里不要求大家诊断他得了什么病，也不要求给他开药，只选一个更稳妥的下一步方案。请记住三个线索：已经服过药、还没核对成分、聚餐可能喝酒。下一页有三个方案，答案不会藏在复杂医学知识里。

28 | 你会替小苏选哪个方案？

主讲：乙 建议：90 秒 累计：31:00—32:30

舞台提示：阅读 10 秒+举手约 25 秒；甲负责观察，乙主讲。

乙：请看三个方案。A，两盒一起吃，聚餐少喝一点。B，先核对成分，拿不准问药师，在没有确认之前先不喝酒。C，加抗生素预防一下，明天再看。大家先自己想十秒。

【静默 10 秒】甲依次邀请选 A、B、C 的同学举手，每个选项约 5 秒；乙观察，不要求任何人解释。

乙：这一题里，B 包含的都是我们已经练过的动作；A 和 C 则各自跳过了关键信息。请保留自己的选择，下一页我们按三条线索逐项核对。即使刚才已经猜到答案，也可以再看一遍：你是凭“这个选项最长”选的，还是确实找到了成分、酒精和抗生素三个判断点？

29 | 答案 B：三个判断点，全都用上了

主讲：乙 建议：90 秒 累计：32:30—34:00

舞台提示：乙揭晓；甲补充就医边界约 15 秒，再交回乙。

乙：答案是 B。我们把题目拆成三步。第一，另一盒药成分不清楚，不能因为症状还在就直接叠加。第二，具体药物的饮酒要求没有确认，先不喝比凭酒量判断更稳妥。第三，题目没有提供使用抗生素的依据，“预防一下”不能替代医生评估。这三条一起组成了更有依据的下一步。

甲：也补充一句，B 不是要求小苏一直待在宿舍查说明书。如果症状持续、加重，或者出现呼吸困难、明显意识异常等情况，行动就应该转为及时就医或急救。

乙：所以合理用药不是背出一个永远适用的药方，而是根据已经掌握的信息，选对接下来的动作。今天这道题不难，目的是让大家能把这个顺序带回真实生活。

本页依据：S2; S4; S9; S11; S12

30 | 药可以常备，判断不能省略

主讲：乙 建议：60 秒 累计：34:00—35:00

舞台提示：甲乙共同收尾；参考文献附页不逐页讲解。

乙：最后，我们把今天的内容收在三句话里。第一，先看说明书，再做用药决定，不让包装和熟悉感替我们判断。第二，核对重复成分，并记录已经服用的药物、时间和用量。第三，遇到不确定的信息，向医生或药师询问；该就医的时候，不继续靠自己试药。

甲：希望下一次室友拿出药盒时，大家能多做一个核对动作，多问一个具体问题。

乙：药可以常备，判断不能省略。谢谢大家。我们的数据出处和参考资料放在后面的附页，方便课后查阅。

【留出约 10 秒结束停顿；不在 35 分钟内另加开放讨论。】

互动答案速查

题目	题目页	揭晓位置	答案
开场选择	2	3	B
重复成分	9	10	C
聚餐饮酒	19	19 页口头+20 页提示	B
综合挑战	28	29	B

参考资料

[S1] 国家卫生健康委等（2020）《关于加强医疗机构药事管理促进合理用药的意见》

<https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202002/fdb7240014db4d49827ca25bbb41b177.shtml>

[S2] FDA. Don't Overuse Acetaminophen.

<https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/dont-overuse-acetaminophen>

[S3] Wolf MS, et al. Risk of Unintentional Overdose with Non-Prescription Acetaminophen Products. J Gen Intern Med. 2012;27:1587–1593. DOI: 10.1007/s11606-012-2096-3.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3509295/>

[S4] CDC. Healthy Habits: Antibiotic Do's and Don'ts.

<https://www.cdc.gov/antibiotic-use/about/>

[S5] Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022;399:629–655. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)02724-0.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8841637/>

[S6] FDA (2023) Updating warnings to improve safe use of prescription stimulants used to treat ADHD and other conditions.

<https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-communications/fda-updating-warnings-improve-safe-use-prescription-stimulants-used-treat-adhd-and-other-conditions>

[S7] 市场监管总局《关于防范保健食品功能声称虚假宣传的消费提示》

https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2023/art_d03ccbcf0c7e482198c4adfa23f9e59a.html

[S8] NHS. Antihistamines.

<https://www.nhs.uk/medicines/antihistamines/>

[S9] NIAAA. Alcohol-Medication Interactions: Potentially Dangerous Mixes.

<https://www.niaaa.nih.gov/health-professionals-communities/core-resource-on-alcohol/alcohol-medication-interactions-potentially-dangerous-mixes>

[S10] NHS Specialist Pharmacy Service. Advising on missed or delayed doses of medicines.

<https://sps.nhs.uk/articles/advising-on-missed-or-delayed-doses-of-medicines/>

[S11] CDC. Manage Common Cold.

<https://www.cdc.gov/common-cold/treatment/index.html>

[S12] NHS. Anaphylaxis.

<https://www.nhs.uk/conditions/anaphylaxis/>

[S13] NHS. Omeprazole.

<https://www.nhs.uk/medicines/omeprazole/>

[S14] Simons FER, Simons KJ. H1 Antihistamines: Current Status and Future Directions. *World Allergy Organ J.* 2008;1:145–155.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3650962/>